Poder Judiciário
Estado de Mato Grosso do Sul
Paranaíba
2ª Vara Cível

SENTENÇA

Autos 0805074-35.2023.8.12.0018
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: Clarisminda de Souza Vieira
Réu: Município de Paranaíba e outro

Vistos etc.

Trata-se *Ação de Obrigação de Fazer* c/c Antecipação de Tutela promovida por Clarisminda de Souza Vieira, em face do Município de Paranaíba e Estado de Mato Grosso do Sul, todos qualificados nos autos, na qual a autora alega que conta atualmente com 82 (oitenta e dois) anos de idade e que é portadora de sequelas de acidente vascular cerebral, hipertensão arterial, disfagia e hipotireoidismo, patologias compatíveis com os CIDs I69.4, I10, R13 e E03. Assevera que, diante de seu quadro clínico, foi indicado à autora o tratamento na modalidade home care, contudo, ao pleitear o fornecimento do aludido tratamento junto aos réus, não obteve êxito. Assim discorrendo, requereu a concessão de liminar para determinar que os réus prestem assistência à saúde na modalidade home care, conforme prescrição médica. Pugnou pela condenação dos réus ao fornecimento dos medicamentos Sertralina 50mg, Domperidona 10mg, Eliquis 5mg e Lamotrigina 100mg, bem como ao fornecimento de fraldas geriátricas tamanho XG. Juntou documentos, requereu a justiça gratuita e deu valor à causa.

O parecer técnico do NAT encontra-se às f. 52/65.

O Município de Paranaíba manifestou-se sobre o pedido de tutela antecipada às f. 66/77, sustentando a impossibilidade de concessão de tutela antecipada contra a fazenda pública, diante da ausência dos requisitos para a concessão do pedido liminar.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 20/04/2024 às 09:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805074-35.2023.8.12.0018 e código STgPk06z.

Citado, o Estado de Mato Grosso do Sul pugnou pelo indeferimento do pedido de tutela antecipada (f. 78/82).

A liminar foi deferida às f. 83/101.

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contestação às f. 104/132, preliminarmente, impugnou o valor da causa pelo objeto da causa ser de valor inestimável, sustentou a ausência de interesse processual. No mérito, sustentou a impossibilidade de atendimento domiciliar em home care para cuidados 24 (vinte e quatro) horas por dia, bem como que não há previsão normativa acerca do dever de fornecimento de fraldas geriátricas pelo SUS. Asseverou sobre a aplicação da tese firmada pelo STJ tema 106. Alegou a impossibilidade de fornecimento de medicamento *off label.* Acrescentou sobre a competência do município para execução dos serviços de atenção domiciliar e da necessidade da frequência do atendimento ser determinada pela equipe municipal, pugnando pela improcedência do pedido.

O Município de Paranaíba ofertou contestação escrita às f. 143/154, aduzindo, preliminarmente, a falta de interesse processual do autor, uma vez que o direito à saúde não é negligenciado. No mérito, pugnou pela improcedência da ação, sob o argumento que o SUS disponibiliza tratamento para a doença em questão. Alegou ser indevida a condenação ao pagamento de custas processuais e a fixação de multa cominatória e pugnou que, no caso de procedência da ação, o tratamento seja realizado com medicação do SUS e que o autor apresente orçamentos de no mínimo 03 (três) estabelecimentos, na hipótese de sequestro de verbas públicas.

Impugnação à contestação às f. 166/175.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora pugnou pela produção de prova pericial (f.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 20/04/2024 às 09:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805074-35.2023.8.12.0018 e código STgPk06z.

175), e o Município de Paranaíba pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (f. 182), enquanto o Estado de Mato Grosso do Sul quedou-se inerte (f. 183).

É o relatório. DECIDO.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência promovida por Clarisminda de Souza Vieira em face do Município de Paranaíba e do Estado de Mato Grosso do Sul, todos qualificados nos autos.

Prefacialmente, assinalo que a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelos réus não merece prosperar, porquanto a lei não exige o esgotamento da via administrativa como condição para propositura de ação postulatória de tratamento médico.

Veja-se a jurisprudência do e. TJMS:

> *"(...) PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE FORMULAÇÃO PRÉVIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REJEITADA – MÉRITO – PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS CARDÍACOS – NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS (...) O exaurimento da via administrativa não é requisito para a obtenção da tutela jurisdicional, tendo a parte interessada a prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário (...)"* (TJMS. Apelação/Remessa Necessária n. 0800329-72.2015.8.12.0024, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 26/06/2018, p: 28/06/2018) Grifei.

Destarte, rejeito a preliminar aventada.

Não havendo outras questões preliminares pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 20/04/2024 às 09:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805074-35.2023.8.12.0018 e código STgPk06z.

Como se sabe, o magistrado tem o poder de decidir sobre a real necessidade da dilação probatória, de tal sorte que, entendendo que os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação de seu livre convencimento, poderá dispensar a produção de outras provas, proferindo desde logo sua decisão. A doutrina explana o seguinte entendimento:

> *"(...) o juiz avaliará a necessidade, ou não, de produção de provas tendentes à formação de seu convencimento sobre a pertinência da pretensão deduzida em juízo, provas essas respeitantes, exclusivamente, às questões de fato (da mihi facto, dabo tibi ius). Concluindo pela negativa, conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença de mérito, dispensada, assim, a fase instrutória, sem dúvida alguma a mais demorada e onerosa de todas as demais fases processuais (...)"* (Antônio Carlos Marcato *in* Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas. 2004, p. 983)

> *"(...) Em verdade, no princípio da avaliação da prova encontram-se englobados todos os conteúdos do livre convencimento, da motivação e da persuasão, pois todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentados (...)"* (Rui Portanova *in* Princípios do Processo Civil. São Paulo: Editora Livraria do Advogado, 2003. p. 218-219)

Veja-se o entendimento do e. TJMS:

> *"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS MÉDICOS – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA (...) cabe ao julgador avaliar as provas produzidas, sendo que se na visão do magistrado as provas apresentadas nos autos mostraram-se adequadas e suficientes, deve ser prestigiada a valoração do conjunto probatório e o livre convencimento motivado que lhe foi conferido, não havendo que se falar em cerceamento do direito*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 20/04/2024 às 09:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805074-35.2023.8.12.0018 e código STgPk06z.

de defesa. (...)" (TJMS – AC 2011.019030-3. Rel. Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, 3ª Turma Cível. Julgado em 19/07/2011) Grifei.

Dito isso, tenho que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, visto que a matéria fática encontra-se suficientemente comprovada pelos documentos existentes nos autos, o que dispensa a a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

Sustentam os réus, em síntese, não estarem presentes os requisitos necessários para compeli-los ao fornecimento dos medicamentos descritos na exordial.

O parecer do NAT de f. 121/136 concluiu o seguinte:

Considerando que a paciente está sendo atendida pelo SUS.
Considerando que Cloridrato de Sertralina, Domperidona, Apixabana não estão padronizados na RENAME 2022.
Considerando que Lamotrigina está padronizada na RENAME 2022, sob o CEAF, disponibilizada através de PCDTs de Epilepsia e do Transtorno Afetivo Bipolar, o registro na ANVISA tem indicação para tratamento de epilepsia e TAB, sendo que os documentos médicos apresentados não indicam estas doenças (uso off label), não indicam presença de convulsões ou dor neuropática (pode ser uma indicação).
Considerando que a paciente está cadastrada no PCDT de TAB, e recebeu lamotrigina até 20/04/2023), depois não renovou sua autorização.
Considerando que a RENAME 2022 tem padronizado no CBAF medicamentos antidepressivos (Amitriptilina, Clomipramina, Nortriptilina, Fluoxetina), anticonvulsivantes (Carbamazepina, Fenitoína, Fenobarbital, Valproato de Sódio), antinauseante (Metoclopramida), anticoagulante oral (Varfarina), antiagregante plaquetário (Ácido Acetilsalicílico), bem como oferece outros medicamentos através dos PCDTs de Epilepsia e Dor Crônica (item IX).
Considerando as evidências científicas disponíveis, falta de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 20/04/2024 às 09:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805074-35.2023.8.12.0018 e código STgPk06z.

informações sobre tratamentos realizados, não foram apresentados resultados de exames complementares, quadro clínico que dificulta o uso de varfarina para anticoagulação profilática (acamada, polifarmácia).

Considerando a Lei Orgânica da Saúde N. 8.080, de 19 de setembro de 1990, artigo 2º, § 2º - O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade;

Considerando a obrigação familiar de prestar assistência básica ao paciente e que na ocasião da alta hospitalar os familiares recebem treinamento e orientações sobre os cuidados domiciliares a serem prestados;

Considerando Lei Orgânica da Saúde N. 8.080, de 19 de setembro de 1990, capítulo II dos Princípios e Diretrizes do SUS, artigo 7º, IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;

Considerando que o serviço de home care e os profissionais de enfermagem para cuidados domiciliares contínuos não estão padronizados em nenhuma lista oficial de serviços para disponibilização através do SUS, no âmbito do Município ou do Estado;

Considerando Portaria nº 825, de 25 de abril de 2016 que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e atualiza as equipes habilitadas;

Considerando artigo 17 da Portaria nº 825, de 25 de abril de 2016 que define as Equipes Multiprofissionais de Atendimento Domiciliar (EMAD) Médicos, Enfermeiros, Auxiliares/Técnicos de Enfermagem e Fisioterapeutas ou Assistentes Sociais e Equipes Multiprofissionais de Apoio (mínimo de 03 profissionais) - assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo, farmacêutico e terapeuta ocupacional;

Considerando que os atendimentos multiprofissionais solicitados são disponibilizados pela Rede Pública de Saúde, por profissionais lotados na Rede de Atenção Básica do Município (UBS Unidade Básica de Saúde e UBSF Unidade Básica de Saúde da Família) e Serviço de Atendimento Domiciliar SAD, através de visitas domiciliares preconizadas;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 20/04/2024 às 09:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805074-35.2023.8.12.0018 e código STgPk06z.

Considerando que embora prescrito o atendimento de enfermagem 24h, este Núcleo não identificou parâmetros técnicos nos documentos médicos que justifiquem a necessidade de um profissional de enfermagem para a realização dos cuidados domiciliares à Autora, uma vez que se trata de procedimentos de baixa complexidade, podendo ser prestados pelos próprios familiares mediante treinamento e orientação pela equipe de saúde através de visitas domiciliares e na ocasião da alta hospitalar;

Considerando a existência do SAD e demais serviços da rede de atenção que realizam atendimentos domiciliares e que não consta nos autos documento médico que descreve que a Autora será acompanhada pela equipe do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) ou que ao menos tenha sido solicitado;

Considerando que o pedido de técnico de enfermagem contínuo em Home Care trata-se de demanda individualizada, de suporte ocupacional e de cuidados básicos que poderiam ser realizados por familiares mediante treinamento e orientação pela equipe de saúde através de visitas domiciliares e na ocasião da alta hospitalar;

Considerando que, de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 11, de 26 de janeiro de 2006 da ANVISA, o serviço de home care, seja ele público ou privado, deve fornecer todos os equipamentos, insumos, medicamentos e recursos humanos necessários ao atendimento da necessidade do paciente. Logo, caso os pleitos autorais venham a ser indicados, devem ser fornecidos pela empresa de home care se contratada.

Considerando que fraldas descartáveis são classificadas como produtos de higiene pessoal, não está padronizado, por isso não é oferecido pelo SUS em nosso Estado, mesmo pacientes em regime de internação hospitalar não são atendidos com fralda descartável, ficando a família responsável pela sua aquisição durante o período de internação;

Considerando que fraldas descartáveis apresentam benefícios à higiene dos pacientes, porém não são de vital importância para prevenção ou recuperação do estado de saúde, uma vez que medidas complementares são necessárias para prevenção/recuperação de assaduras e outras lesões de pele;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 20/04/2024 às 09:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805074-35.2023.8.12.0018 e código STgPk06z.

Considerando que a disponibilidade de fraldas descartáveis no SUS pode variar de acordo com as políticas de saúde em diferentes estados e municípios.
Considerando que não há informações de que o Município de Paranaíba/MS possui políticas públicas para dispensação de fraldas descartáveis.
Considerando que há a Portaria GM/MS nº 675 de 07 de junho de 2023 que altera o Anexo LXXVII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para estabelecer a gratuidade do elenco de medicamentos, incluindo fraldas geriátricas descartáveis do Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB para os beneficiários do Programa Bolsa Família.
Diante do exposto, este Núcleo de Apoio Técnico é favorável ao pedido Apixabana; e desfavorável ao pedido de Cloridrato de Sertralina, Domperidona, Lamotrigina. Favorável ao Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) multiprofissional, oferecido pelo SUS, dentro dos moldes da Portaria citada acima que define as equipes e serviços oferecidos, de acordo com a tabela SIGTAP. Desfavorável ao pedido de atendimentos domiciliares em regime de Home Care. Desfavorável ao pedido de Técnico de Enfermagem 24h por dia. Desfavorável ao pedido de fraldas descartáveis.

Dito isso, observo que a responsabilidade dos réus pelo custeio de tratamento médico a quem dele necessita mas não dispõe de recursos financeiros para aquisição é evidente, pois o direito à preservação da saúde e da vida do cidadão é garantido pela Constituição Federal. Sobre o tema, José Afonso da Silva[1] ensina o seguinte:

> *"(...) E há de informar-se pelo princípio de que o direito igual à vida de todos os seres humanos significa também que, nos casos de doença, cada um tem o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independentemente de sua situação econômica, sob pena de não ter muito valor sua consignação em normas constitucionais".*

[1] *in* Curso de Direito Constitucional Positivo – 26. ed. rev. e atual. nos termos da Reforma Constitucional, até a Emenda Constitucional n. 48, de 10.8.2005 – São Paulo: Malheiros, 2006. p. 308)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 20/04/2024 às 09:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805074-35.2023.8.12.0018 e código STgPk06z.

A jurisprudência tem adotado o seguinte entendimento:

"(...) Direito à saúde. Paciente que, acometido por úlcera, necessita de oxigenoterapia em câmara hiperbárica. Tratamento que melhora as funções orgânicas do paciente, pelo que está inscrito à seara da tutela à vida. Precedentes. (...) É possível o custeio do procedimento em rede privada e mesmo o seqüestro da verba pública se necessário. Ponderação de interesses. Jurisprudência uníssona do TJRJ. Recurso conhecido e desprovido. (...) O direito à saúde compõe o núcleo irredutível e necessário do direito à vida. Este, por sua vez, é o bem jurídico primeiro e mais relevante na tutela da pessoa humana, cuja subtração implica no esvaziamento das premissas de legitimidade e da razão de ser do Poder Público. Trata-se, na verdade, de mais do que um direito: é pressuposto metapolítico para a própria concepção do Estado. Neste sentido, a Constituição Federal aparelha normativamente, de forma ampla e irrestrita, a conservação da vida e da integridade física. Além das garantias ligadas imediatamente a este fim, todas as outras cláusulas constitucionais, em última análise, reconduzem à fruição plena da vida. Logo, estando a pretensão posta em ordem a viabilizar o acesso a qualquer bem ou procedimento capaz de melhorar as funções orgânicas ou corrigir eventuais distúrbios, está-se sob o manto da tutela à vida. (...) Na esteira do que se encimou e dada a magna relevância do direito em tela, é possível a internação na rede privada ou mesmo o seqüestro da verba pública, de modo a instrumentalizar uma maior amplitude no acesso ao tratamento. Afinal, se os entes públicos não conseguem acompanhar a demanda com infraestrutura adequada, podem locar os serviços particulares para complementar sua rede de atendimento. Tudo isso se justifica na garantia do mínimo existencial. Entender de forma diferente seria dar fuga à responsabilidade imposta pela Constituição e prestígio à letargia funcional dos entes públicos nas prestações de saúde. (...)" (TJ-RJ - RI: 0416700-27.2013.8.19.0001, Relator: LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Primeira Turma Recursal Fazendária, Data de Publicação: 27/01/2015) Grifei.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 20/04/2024 às 09:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805074-35.2023.8.12.0018 e código STgPk06z.

Veja-se a jurisprudência do e. TJMS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO SUSCITADA DE OFÍCIO PELO REVISOR – REJEITADA – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – SEQUESTRO DE VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO. (...) II - Todos os entes federativos são responsáveis pela promoção da saúde dos cidadãos, exatamente porque o art. 196, da CF/88, vale-se do termo Estado para abranger tanto a União, quanto os Estados e os Municípios. Precedente do STJ. II - Todos têm o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, mormente quando se trata de patologia grave e a cirurgia é imprescindível para tratamento mais eficiente. III- Cabe ao magistrado determinar as medidas que entende eficazes à efetivação de suas decisões, consoante permite o art. 461, §5º, do Código de Processo Civil (CPC), podendo, caso entenda necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio. No que tange ao argumento de que havia necessidade de apresentação de três orçamentos para o bloqueio de valores e da excessividade do valor cobrado, tenho que a questão está preclusa, uma vez que o Estado, instado a se manifestar, deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido. Desse modo, diante da responsabilidade solidária dos entes públicos, o bloqueio poderá recair sobre as contas de um ou de outro ente. (TJMS - Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson; 3ª Câmara Cível; julgamento: 16/02/2016) Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS – MÉRITO – NECESSIDADE DE CIRURGIA – OSTEOARTROSE AVANÇADA – DEVER CONSTITUCIONAL – ART. 196, CF – LAUDO MÉDICO (...) 1. A Carta Magna de 1988 erige a saúde

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 20/04/2024 às 09:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805074-35.2023.8.12.0018 e código STgPk06z.

como um direito de todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. 2. Havendo laudo médico informando a doença a qual está acometida a autora bem como a necessidade da realização da cirurgia para o tratamento daquela, somando-se ao fato de a União, o Estado e o Município têm o dever de garantir a saúde a todos os que dela necessitam, não é crível que vise o Estado, por meio de edição de uma Portaria, restringir o alcance de uma norma constitucional (artigo 196), a ponto de vedar um direito garantido. (TJMS - Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Data do julgamento: 26/01/2016; Data de registro: 29/02/2016) Grifei.

O TJMS igualmente reconhece a responsabilidade estatal pelo fornecimento do tratamento na modalidade home care às pessoas que deles necessitem, nos termos seguintes:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO "HOME CARE" – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR- REJEIÇÃO – MÉRITO - AUTORA PORTADORA DE SEQUELAS DE AVC – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CF – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - SOLIDARIEDADE NO ATENDIMENTO – DIREITO À SAÚDE – RE 855.178 (TEMA 793) - SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS VOLUNTÁRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS. É prescindível o prévio procedimento administrativo ou seu esgotamento para o ajuizamento da presente demanda, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdiçã (art, 5ºminciso XXXV, da CF) mormente por se tratar de tratamento de saúde. Compete aos entes públicos a corresponsabilidade de providenciar o tratamento pretendido, posto que sua obrigação decorre do

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 20/04/2024 às 09:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805074-35.2023.8.12.0018 e código STgPk06z.

texto constitucional. Portanto, o Município (lato sensu) e o Estado, de forma subsidiária, tem a obrigação de fornecer os meios necessários à proteção e manutenção do direito à vida, à saúde e a dignidade do paciente. A solidariedade de todos os entes públicos perante o necessitado mantém-se incólume, isto é, o reconhecimento de quem deverá suportar o ônus financeiro com o tratamento não é imposta em face da dela, refere-se à lide secundária que deve tratar da compensação entre os entes públicos. (...)" (TJMS. Apelação/Remessa Necessária n. 0801291-23.2022.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j: 23/03/2023, p: 24/03/2023) Grifei.

Vale anotar ainda que, em relação à pessoa idosa, o fornecimento de atendimento de saúde em regime de home care é compatível com a regra insculpida no art. 15, inc. IV, da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Veja-se a redação do dispositivo legal:

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas.
(...)
<u>IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para as pessoas idosas abrigadas e acolhidas por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o poder público, nos meios urbano e rural;</u> (...)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 20/04/2024 às 09:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805074-35.2023.8.12.0018 e código STgPk06z.

A jurisprudência tem admitido a imposição da obrigação de disponibilização de tratamento médico em regime de home care para pessoa idosa. Senão vejamos:

> *"E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE HOME CARE PARA TRATAMENTO DO MAL DE PARKINSON. DIREITO AO FORNECIMENTO EVIDENCIADO POR LAUDO MÉDICO NOS AUTOS – NECESSIDADE COMPROVADA – ATESTADO MÉDICO QUE EVIDENCIA A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR PLEITEADO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA NO TRATAMENTO DO AGRAVADO DEMONSTRADAS – RECURSO DESPROVIDO. Os artigos 196 e 198 da Constituição da República preveem que a saúde é direito do cidadão e dever dos entes públicos, que se desincumbirão das ações e serviços de saúde, compondo um sistema único de saúde, financiado com recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Há evidência substancial de que o Autor está acometido de doença gravíssima, Esclerose Lateral Amiotrófica, e indicação médica de urgência e imprescindibilidade do tratamento domiciliar. Assim, preenchidos os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência.* (TJMS. Agravo de Instrumento n. 2000936-88.2017.8.12.0000, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Nélio Stábile, j: 28/11/2017, p: 28/11/2017) Grifei.

Por outro lado, convém mencionar que, conforme apontado pelo Núcleo de Apoio Técnico, o pleito referente à disponibilização de técnico de enfermagem por 24h por dia não se mostra razoável, haja vista a possibilidade de dispensação de cuidados básicos ao paciente por familiares ou cuidadores.

Veja-se a jurisprudência do e. TJMS:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 20/04/2024 às 09:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805074-35.2023.8.12.0018 e código STgPk06z.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – PACIENTE COM SEQUELAS DE TRAUMATISMO ENCEFÁLICO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM FORNECIMENTO DE INSUMOS, APARELHOS E SERVIÇO HOME CARE – ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DEVIDAMENTE GARANTIDO PELO JUIZ - PRETENSÃO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM QUANTO À NECESSIDADE DE CUIDADOS COMUNS (HIGIENE, ALIMENTAÇÃO ETC.), DIVERSOS DOS PROCEDIMENTOS TÍPICOS DE INTERNAÇÃO – POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA POR FAMILIARES OU CUIDADORES. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E APARELHOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I) A prestação de serviços via home care não se confunde com o atendimento que pode ser prestado pela família ou por cuidador. O papel de proporcionar ao paciente cuidados comuns de higiene e alimentação podem ser desempenhados por estes últimos, ao passo que o serviço home care tem a função de administrar procedimentos típicos de internação hospitalar, daí a necessidade de profissionais especializados para prestar o tratamento no ambiente doméstico. No caso, constatado que o autor pede também o atendimento para cuidados comuns (alimentação, higiene etc.), diversos da internação domiciliar e que podem ser prestados por familiares ou cuidadores, deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visou obrigar o Município a custear enfermeiro por 12h diárias. II) É obrigação do Estado assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação e aos procedimentos necessários para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. O Estado tem o dever de assegurar o bem-estar do cidadão, o que é ressaltado logo no Preâmbulo da Constituição Federal, bem como em seu art. 196, sendo, ademais, fundamento da República o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que, comprovada a necessidade dos insumos solicitados, acolhe-se o pedido para determinar o fornecimento. III) Recurso conhecido e parcialmente provido, em parte com o parecer. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1403979-09.2022.8.12.0000, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 27/06/2022, p: 01/07/2022) Grifei.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 20/04/2024 às 09:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805074-35.2023.8.12.0018 e código STgPk06z.

Nesse sentido, insta colacionar a conclusão do parecer técnico (f. 60):

> **V - Se há risco iminente à vida do paciente;**
> Não há dados clínicos informados nos autos que indiquem risco iminente à vida da paciente. Os cuidados básicos à paciente podem ser perfeitamente prestados pelos familiares no domicílio, devidamente treinados, orientados e acompanhados pelas equipes multidisciplinares de Saúde da Família através do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e/ou Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD.

Nesse sentido, a Portaria GM 635/2023 do Ministério da Saúde regulamenta a atuação das equipes multidisciplinares, que possui dentre suas áreas de atuação a equipe de saúde da família, a qual incumbe o atendimento e orientações necessárias à família da parte autora, conforme mencionado no parecer.

Ademais, em que pese o parecer desfavorável do NAT quanto ao fornecimento do fármaco "Lamotrigina 100mg", cumpre ressaltar que o fármaco encontra-se padronizado na RENAME (item VII, f. 60) e há prescrição médica nos autos, inexistindo, assim, qualquer óbice ao seu fornecimento à parte autora.

No que se refere aos medicamentos "Sertralina 50mg", "Domperidona 10mg" e "Eliquis 5mg" considerando que não se encontram padronizados na RENAME, consoante indicado no parecer do NAT, (item VII, f. 60), necessária a análise dos requisitos impostos pela jurisprudência.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156 que tramitava pelo rito dos recursos especiais repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos que estão fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS), desde que presentes três requisitos, quais sejam: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 20/04/2024 às 09:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805074-35.2023.8.12.0018 e código STgPk06z.

da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Veja-se:

> *"EMENTA ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 20/04/2024 às 09:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805074-35.2023.8.12.0018 e código STgPk06z.

> *meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015."* (RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156 – RJ (2017/0025629-7) - RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES – Julgado em 25.04.2018) Grifei.

Destarte, embora o parecer do NAT tenha sido desfavorável (item "XI", f. 63/64), o laudo médico de f. 22/23 comprova a necessidade dos medicamentos pleiteados, bem como atesta a prévia utilização dos fármacos fornecidos pelo SUS e sua ineficácia para o tratamento.

Quanto ao segundo requisito, qual seja a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito, entendo que ao deferir à parte autora os benefícios da justiça gratuita implicitamente este juízo reconheceu a hipossuficiência financeira da mesma, que inclusive é assistida pela Defensoria Pública.

Por fim, o terceiro requisito, qual seja, o registro dos medicamentos junto à ANVISA, encontra-se no tópico IV do parecer técnico do N.A.T (f. 60).

Dito isso, entendo que restaram integralmente preenchidos os requisitos apresentados no julgamento do REsp nº 1.657.156, de modo que a procedência do tratamento e medicamentos pleiteados é medida que se impõe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 20/04/2024 às 09:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805074-35.2023.8.12.0018 e código STgPk06z.

Ainda, em relação ao pleito para fornecimento de fraldas geriátricas, em que pese o parecer desfavorável do NAT, há que se considerar, in casu, a avançada idade da parte autora, que conta com mais de 82 (oitenta e dois) anos de idade, e encontra-se acamada, não anda e não fala, consoante atestado no documento médico de f. 25, presumindo-se a imprescindibilidade do seu uso, impondo-se, portanto, o deferimento do pleito quanto a este ponto.

Diante desse contexto, é inegável o dever estatal de fornecer o tratamento pleiteado na prefacial em favor da paciente, observados os limites fixados neste decisum.

Outrossim, conforme a decisão liminar referendada pelo plenário do STF nos autos do RE 1366243 (Tema 1234), nas ações envolvendo medicamentos ou tratamento padronizados, deve-se observar a repartição de atribuições definidas pelo SUS. Em relação aos tratamentos ou fármacos não padronizados, deverá ser respeitada a composição do polo passivo eleita pela parte autora. É o que se extrai do seguinte trecho:

> *"5.1 nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;*
> *5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;"* [2] (Grifei).

[2] https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=6335939&numeroProcesso=1366243&classeProcesso=RE&numeroTema=1234

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 20/04/2024 às 09:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805074-35.2023.8.12.0018 e código STgPk06z.

In casu, de acordo com o parecer do NAT, não foi possível indicar qual ente público responsável pelo fornecimento do serviço de *home care* e pelos medicamentos não padronizados na RENAME. Veja-se (f. 78):

> *VIII - Indicar, quando possível, qual o ente público responsável pelo atendimento do paciente, segundo as normas do Sistema Único de Saúde (SUS);*
> *O Cloridrato de Sertralina, Domperidona, Apixabana não estão padronizados, portanto, não é possível indicar ente público responsável, segundo as normas do SUS.*
> *A Lamotrigina, conforme grupo de financiamento da Assistência Farmacêutica, faz parte do grupo 2, medicamentos financiados pelas Secretarias de Estado da Saúde para tratamento das doenças contempladas no CEAF.*
> *O Município é responsável pelo atendimento do pedido de atendimento multidisciplinar.*
> *O serviço de home care; os profissionais de enfermagem para cuidados domiciliares contínuos não estão padronizados em nenhuma lista oficial de serviços para disponibilização através do SUS, no âmbito do Município ou do Estado. Assim, não há atribuição exclusiva do Município ou do Estado em fornecê-los.*
> *As fraldas descartáveis não estão padronizadas no SUS, portanto não é possível indicar o ente público responsável pelo atendimento do pedido segundo as normas do SUS.*
> *No entanto, a disponibilidade de fraldas descartáveis no SUS pode variar de acordo com as políticas de saúde em diferentes estados e municípios.*
> *Não há informações de que o Município de Paranaíba/MS possui políticas públicas para dispensação de fraldas descartáveis. Recentemente foi publicada a Portaria GM/MS nº 675 de 07 de junho de 2023 que altera o Anexo LXXVII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para estabelecer a gratuidade do elenco de medicamentos, incluindo fraldas geriátricas descartáveis do Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB para os beneficiários do Programa Bolsa Família.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 20/04/2024 às 09:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805074-35.2023.8.12.0018 e código STgPk06z.

Logo, em relação ao tratamento de home care e fornecimento dos medicamentos "Sertralina 50mg", "Domperidona 10mg" e "Elquis 5mg", além das fraldas geriátricas, a obrigação deve recair sobre ambos réus.

Contudo, a obrigação pelo fornecimento do fármaco "Lamotrigina 100mg" deve recair apenas sobre o corréu Estado de Mato Grosso do Sul.

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na prefacial, para o fim de:

a) condenar os réus Município de Paranaíba-MS e o Estado de Mato Grosso do Sul, solidariamente, a fornecerem à autora, gratuita e continuamente, tratamento na modalidade home care, com acompanhamento médico semanal, técnico de enfermagem 07 dias na semana, em frequência a ser verificada pelo ESF, fisioterapia 05 x por semana, fonoaudiologia 05 x por semana, visita enfermeira semanal, e nutricionista mensal;

b) condenar os réus Município de Paranaíba e Estado de Mato Grosso do Sul, solidariamente, a fornecerem à autora, gratuita e continuamente, os medicamentos denominados "Sertralina 50mg", "Domperidona 10mg" e "Elquis 5mg", além de fraldas geriátricas tamanho XG;

c) condenar o réu Estado de Mato Grosso do Sul a fornecer à autora, gratuita e continuamente, o medicamento denominado "Lamotrigina 100mg", conforme prescrição médica.

Por conseguinte, convalido a liminar de f. 83/101.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 20/04/2024 às 09:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805074-35.2023.8.12.0018 e código STgPk06z.

Sem condenação nas custas processuais, nos termos do art. 24, inciso I, da Lei Estadual 3.779/2009. Condeno o Município de Paranaíba ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FUNADEP, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista a reduzida complexidade e duração da demanda, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Outrossim, considerando a tese firmada pelo pretório excelso no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), no sentido de que "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra", condeno o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários ao FUNADEP, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).

Sentença sujeita a reexame necessário. Transcorrido o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos à instância superior.

Caso haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte recorrida para ofertar contrarrazões recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC. Havendo apelo adesivo (art. 1.010, § 2º, do CPC), intime-se o apelante para apresentar contrarrazões. Após, considerando que o art. 1.010, § 3º, do CPC preconiza que a competência para exercer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação é do juízo *ad quem*, remetam-se os autos ao e. TJMS para processamento do recurso.

Se a parte recorrida for a Fazenda Pública, o Ministério Público ou pessoa assistida pela Defensoria Pública, o prazo para contrarrazões deverá ser contado em dobro, nos termos dos art. 180, 183 e 186, todos do CPC.

Com o trânsito em julgado, intimem-se as partes e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se com as anotações

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 20/04/2024 às 09:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805074-35.2023.8.12.0018 e código STgPk06z.

e baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Paranaíba, *data da assinatura eletrônica*.

Plácido de Souza Neto

Juiz de Direito

Assinado digitalmente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 20/04/2024 às 09:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805074-35.2023.8.12.0018 e código STgPk06z.